

GUIÓN DE SPEECH — DIAPOSITIVAS 2, 3, 4 Y 5

Marco Teórico: El Self, los Instrumentos y el Bienestar

Duración estimada: 6–8 minutos

CÓMO LEER ESTE GUIÓN

- [DIAPOSITIVA X] = momento en que cambias de slide
 - (pausa) = para 1-2 segundos, deja que el tribunal mire la diapositiva
 - **Negrita** = énfasis oral, eleva ligeramente el tono
 - *Cursiva* = dato técnico, pronuncia con precisión
 - Las indicaciones entre corchetes son para ti, no las lees en voz alta
-

[DIAPOSITIVA 2 — Marco teórico: El self]

(pausa breve — deja que lean el título)

Para entender qué estoy midiendo en este trabajo y por qué tiene sentido medirlo junto, necesito situaros primero en el debate teórico que hay detrás.

El estudio del self —es decir, de cómo nos representamos y valoramos a nosotros mismos— no es nuevo. Tiene **más de ciento treinta años de historia** en psicología, y durante todo ese tiempo ha generado uno de los debates más prolíficos y también más confusos de la disciplina.

La pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿qué es exactamente lo que medimos cuando preguntamos a alguien cómo se ve a sí mismo? ¿Estamos midiendo lo mismo con distintos nombres, o cosas distintas con el mismo nombre?

Y aquí es donde entran las dos falacias que vertebran toda la introducción teórica de mi trabajo.

La **falacia jingle** consiste en usar el mismo término para dos constructos distintos. Por ejemplo, llamar "autoestima" tanto a la valoración global de uno mismo como al autoconcepto específico en el ámbito físico. Son cosas distintas, pero las tratamos como si fueran la misma.

La **falacia jangle** es la contraria: usar términos distintos para lo que en realidad es lo mismo. Por ejemplo, "autoimagen", "autoconcepto" y "autopercepción" se usan a veces de forma intercambiable cuando en realidad miden lo mismo con distinto nombre.

Estas dos falacias han contaminado durante décadas la literatura científica sobre el self, dificultando la acumulación coherente de conocimiento. Y es precisamente por eso que este trabajo trata tanto autoestima como autoconcepto —diferenciándolos— en lugar de colapsar todo bajo un único constructo.

Voy a explicar ahora qué son cada uno y en qué se diferencian.

La **autoestima** es esencialmente **evaluativa y global**: responde a la pregunta "¿cuánto me valoro a mí mismo?". Es un juicio de valor sobre uno mismo como totalidad.

El **autoconcepto**, en cambio, es **descriptivo y multidimensional**: responde a "¿cómo me veo en distintos aspectos de mi vida?". No es mejor ni peor; es más o menos preciso, más o menos diferenciado. Una persona puede tener un autoconcepto académico muy positivo y un autoconcepto físico muy negativo. El promedio de ambos nos daría una autoestima media, pero estaríamos perdiendo información clínicamente relevante.

Esta distinción no es académica: en la práctica clínica, si solo mido autoestima global, puedo pasar por alto déficits muy específicos que son la raíz del problema del paciente.

[DIAPOSITIVA 3 — Un siglo de estudio del self: línea temporal]

(pausa — señala la línea temporal)

Esta diapositiva muestra la evolución del campo, y me parece importante no limitarme a los hitos que aparecen en pantalla, porque la historia real es más rica y nos ayuda a entender por qué hoy seguimos sin consenso total.

Todo empieza con **William James** en 1890, en su obra "The Principles of Psychology". James fue el primero en distinguir entre el *I* —el yo como agente, el que piensa y actúa— y el *Me* —el yo como objeto de conocimiento, lo que uno sabe de sí mismo. Esta distinción filosófica es el punto de partida de toda la psicología del self.

Pero James no pensaba solo en términos individuales. Señaló que el self tiene tres dimensiones: el self material —el cuerpo, las posesiones—, el self social —cómo te perciben los demás—, y el self espiritual —tus valores, tu vida interior. Esto ya anticipa que el self es **multidimensional**.

Doce años después, en 1902, **Charles Cooley** introduce el concepto de "looking-glass self" —el yo-espejo. La idea es que nos vemos a nosotros mismos a través de cómo creemos que nos ven los demás. No es cómo nos ven realmente, sino nuestra percepción de cómo nos ven. Esto incorpora la dimensión **social e intersubjetiva** del autoconcepto, y tiene implicaciones directas para la clínica: en poblaciones que han sufrido rechazo, estigma o violencia, el yo-espejo puede estar severamente distorsionado.

En 1934, **George Herbert Mead** profundiza en esta línea. Para Mead, el self no existe antes de la interacción social: se construye en el diálogo con los otros. Introduce el concepto del "otro generalizado": internalizamos las expectativas y normas del grupo social al que pertenecemos, y eso moldea quiénes creemos ser.

[Este hito no aparece en la diapositiva pero es importante mencionarlo de pasada si quieres mostrar dominio del marco]

En los años cincuenta, **Erik Erikson** sitúa la formación de la identidad del yo como la tarea central de la adolescencia. La "crisis de identidad" adolescente que todos conocemos en psicología clínica viene directamente de Erikson. Esto conecta el self con el desarrollo evolutivo y con la vulnerabilidad específica de la adolescencia —algo muy relevante para los resultados del Bloque C de mi trabajo, sobre obesidad pediátrica.

[Este hito tampoco está en la diapositiva — añádelo si tienes tiempo, omítelo si vas ajustada]

El salto conceptual más importante del siglo XX viene en 1976, con **Shavelson, Hubner y Stanton**. Proponen el modelo jerárquico y multidimensional del autoconcepto: en la cúspide, un autoconcepto

general; debajo, el académico y el no académico; y en la base, subdimensiones específicas —autoconcepto verbal, matemático, físico, social, emocional. Lo fundamental es que estas dimensiones no se reducen entre sí: puedes tener un autoconcepto físico muy alto y uno académico muy bajo. Esta arquitectura explica por qué tratar el autoconcepto como un único número es perder precisión.

Herbert Marsh, en los años noventa, recoge el modelo de Shavelson y lo operacionaliza desarrollando el *Self-Description Questionnaire* —el SDQ— y el *Physical Self-Description Questionnaire* —el PSDQ— para medir el autoconcepto físico de forma multidimensional. Marsh añade además un modelo explicativo, el *Internal/External Frame of Reference*: el autoconcepto se forma comparándonos con los demás —comparación externa— y comparando nuestro rendimiento en distintos dominios propios —comparación interna. Esto explica por qué un estudiante muy brillante puede tener un autoconcepto matemático bajo si se compara con compañeros aún más brillantes.

En 1965, entre Shavelson y el siglo XX, **Morris Rosenberg** publicó su escala —la RSES— que merece mención aparte porque es el instrumento más utilizado en el mundo para medir autoestima: diez ítems, escala Likert de cuatro puntos, de libre acceso, con propiedades psicométricas robustas en más de cincuenta culturas distintas. Su sencillez es su mayor virtud clínica.

Y llegamos a 2003, con el meta-análisis de **Roy Baumeister** y colaboradores, que revisó toda la literatura causal sobre autoestima. Su conclusión fue incómoda para el campo: los efectos causales de la autoestima sobre el rendimiento académico, las relaciones y la salud eran **más modestos de lo que se había afirmado**. Esto generó un debate que todavía no está cerrado y que justifica en parte la necesidad de revisiones como la que presento: necesitamos saber exactamente cuánto, en qué condiciones, y en qué poblaciones, la autoestima predice el bienestar.

[DIAPOSITIVA 4 — ¿Qué medimos exactamente3]

(pausa)

Una vez situado el marco conceptual, la pregunta inevitable es: ¿con qué instrumentos medimos todo esto?

En los meta-análisis del corpus de mi trabajo, los predictores —autoestima y autoconcepto— se midieron principalmente con tres tipos de instrumentos:

La **Escala de Autoestima de Rosenberg** —RSES— para autoestima global. Ya la he mencionado: diez ítems, dos subescalas —autoestima positiva y negativa—, puntuación total de 10 a 40, donde puntuaciones bajas indican mayor autoestima. Es el gold standard mundial.

El **Self-Description Questionnaire** —SDQ, en sus versiones I, II y III según la edad— para autoconcepto multidimensional siguiendo el modelo de Shavelson. Permite obtener un perfil del autoconcepto en múltiples dominios, no un único número.

Y el **Physical Self-Description Questionnaire** —PSDQ— cuando el foco es específicamente el autoconcepto físico, especialmente relevante en los bloques de obesidad pediátrica e imagen corporal.

En cuanto a las variables **resultado** —el bienestar—, los meta-análisis usaron instrumentos muy heterogéneos, que es precisamente uno de los desafíos de esta revisión. Los más frecuentes fueron medidas de **calidad de vida relacionada con la salud** —HRQoL— como el SF-36 o el WHOQOL-BREF, y medidas de **salud mental general** como el GHQ-12 o el PHQ. Esta heterogeneidad es lo que dificulta

una síntesis cuantitativa global y justifica la organización por bloques temáticos que utilizo.

[DIAPOSITIVA 5 — El bienestar tiene cuatro caras]

(pausa — deja que lean los cuatro bloques de la diapositiva)

El bienestar es la variable resultado de todo este trabajo, y es importante que quedemos alineados en que **no es un constructo unitario**. Hay al menos cuatro tradiciones teóricas distintas que lo conceptualizan de manera diferente, y los meta-análisis del corpus las utilizan de forma no siempre equivalente.

La primera es el **bienestar subjetivo o hedónico**, propuesto por **Ed Diener** en los años ochenta. Para Diener, estar bien es tener más emociones positivas que negativas —el balance afectivo— y sentirse satisfecho con la propia vida. Tiene tres componentes: la satisfacción con la vida, el afecto positivo y la ausencia de afecto negativo. Se mide con instrumentos como la *Satisfaction With Life Scale* —SWLS— o el *PANAS*. La crítica a este modelo es que puede capturar bienestar superficial: alguien puede sentirse bien en el corto plazo y sin embargo estar evitando conflictos importantes o no estar creciendo como persona.

La segunda es el **bienestar psicológico o eudaimónico**, propuesto por **Carol Ryff**, con raíces en la filosofía aristotélica: el bienestar no es sentirse bien, sino **vivir bien**, desarrollarse. Ryff propone seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas con otros, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. De estas seis, las más directamente relacionadas con la autoestima y el autoconcepto son la **autoaceptación** y el **propósito en la vida**. Se mide con las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff. Este modelo aparece poco en el corpus de mi trabajo —la mayoría de los meta-análisis clínicos usan HRQoL o síntomas— y eso en sí mismo es un hallazgo: la psicología clínica ha estado más centrada en eliminar el malestar que en promover el florecimiento.

La tercera dimensión es la **calidad de vida relacionada con la salud**, la HRQoL —de las siglas en inglés *Health-Related Quality of Life*—. Es la medida más utilizada en contextos médicos y clínicos porque evalúa el impacto percibido de la condición de salud en el funcionamiento físico, psicológico y social. Se operacionaliza con instrumentos como el **SF-36**, el **EQ-5D** o el **WHOQOL-BREF** de la OMS. Es el tipo de medida predominante en los bloques B y C de mi trabajo —salud somática y obesidad pediátrica— donde el bienestar tiene una dimensión más funcional y ligada a la condición médica.

Y la cuarta, que quizás es la más reciente y menos conocida en clínica, es la **salud mental general o salud mental positiva**, conceptualizada por **Corey Keyes**. Keyes propone que la ausencia de enfermedad mental **no equivale** a salud mental. Son dos continuos independientes: puedes tener un diagnóstico de depresión y, aun así, tener recursos psicológicos que te permiten funcionar bien —lo que Keyes llama *flourishing* con psicopatología—. O puedes no tener ningún diagnóstico pero estar en *languishing*, sin bienestar real. Esta distinción es clínicamente importante: nos recuerda que el objetivo terapéutico no debe ser solo reducir síntomas, sino también promover recursos positivos como el sentido de vida, las relaciones y —precisamente— el autoconcepto y la autoestima.

(Al terminar la diapositiva 5, pausa breve antes de pasar a la siguiente)

Habiendo situado el marco teórico —qué son autoestima y autoconcepto, cómo han evolucionado, con qué los medimos y qué entendemos por bienestar—, ya estamos en condiciones de preguntarnos: ¿por qué era necesario este trabajo? ¿Qué gap en la literatura venía a cubrir?

Paso a la siguiente diapositiva.

[FIN DEL GUIÓN — DIAPOSITIVAS 2 A 5]

Tiempo estimado: 6–8 minutos según ritmo